

Ramowy Plan Wdrożenia Innowacji

Szlakiem ludzi bezdomnych

Autor innowacji: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Stalowej Woli

1. Istota innowacji:

Innowacja opiera się na **Mobilnym Punkcie Higienicznym (MPH)**, czyli przyczepie z prysznicem (400×200 cm, 750 kg), która dociera bezpośrednio do miejsc przebywania osób w kryzysie bezdomności.

Z przodu znajduje się oddzielna maszynownia z instalacją gazową, a wewnątrz podzielono na dwa pomieszczenia: większy przedsionek ze stolikiem, ławkami, szafką i dwoma oknami oraz mniejszą łazienkę z prysznicem, zlewem i lusterkim, doświetlaną wyłącznie oknem dachowym dla zachowania prywatności.

Przyczepa wyposażona jest w dwa zbiorniki na czystą wodę (po 80 l), zbiornik na wodę szarą, kocioł gazowy do podgrzewania wody, instalację elektryczną 230 V zasilaną agregatem 3,8 kW oraz oświetlenie 12 V. Wnętrze ogrzewają dwa grzejniki z funkcją przeciwwymarzaniową, co umożliwia pracę także zimą. MPH służy przede wszystkim do kąpieli i podstawowych zabiegów higienicznych, ale w sezonie chłodnym pełni również funkcję „Kącika ciepła”, gdzie można ogrzać się, napić herbaty i zmienić odzież. To rozwiązanie tańsze i bardziej elastyczne niż stacjonarne łaznie miejskie, pozwalające dotrzeć bezpośrednio do osób najbardziej potrzebujących.

2. Kluczowe wyróżniki rozwiązania

- **Mobilność i elastyczność:** Pozwala na szybką reakcję i zmianę lokalizacji w zależności od potrzeb.
- **Niskie koszty:** Rozwiązanie jest tańsze w utrzymaniu niż budowa stacjonarnej łazni, co czyni je atrakcyjnym dla mniejszych samorządów.
- **Budowanie relacji:** MPH to nie tylko „łazienka na kółkach”, ale przestrzeń do spotkania ze streetworkerem, budowania zaufania i motywowania do dalszych kroków (leczenie, schronisko).

- **Odwrócony model pomocy:** To instytucja wyrusza szlakiem człowieka, eliminując bariery wstydu, lęku przed instytucjami i konieczność formalnej rejestracji.

3. Diagnoza: na jaki problem/potrzebę odpowiada innowacja?

Tradycyjny system pomocy często nie dociera do osób w kryzysie bezdomności. Osoby przebywające poza schroniskami mają krytycznie utrudniony dostęp do higieny, co pogłębia ich wykluczenie, obniża poczucie godności i pogarsza stan zdrowia.

- **Pogłębiająca się skala problemu:** ogólnopolskie badania z 2024 roku wykazują, że choć liczba osób w placówkach rośnie powoli, to liczba osób przebywających **poza systemem (na ulicach, w pustostanach) wzrosła aż o 44,5%**¹ (dane dotyczące Małopolski).
- **Bariery infrastrukturalne:** Osoby bezdomne są często przeganiane z ogólnodostępnych toalet (stacje benzynowe, sklepy), co demotywuje ich do dbania o siebie i zamyka w „błędym kole” wykluczenia.
- **Profil odbiorcy:** Dominującą grupą są mężczyźni w wieku 40-60 lat, ale coraz częściej problem dotyka osób młodych z tzw. „zwykłych rodzin”².
- **Skutki braku higieny:** To nie tylko kwestia zdrowia fizycznego, ale drastyczny spadek poczucia własnej wartości, godności i lęk przed kontaktem z innymi ludźmi.

4. Model Innowacji: Co konkretnie wdrażasz?

Innowacja odwraca tradycyjny model wsparcia: **to instytucja wyrusza szlakiem człowieka**, zamiast oczekiwać, że on pojawi się w placówce. Innowacja opiera się na gotowych elementach udostępnionych na otwartej licencji:

- **Infrastruktura:** specyfikacja techniczna mobilnego kontenera/przyczepy wraz z wyposażeniem.
- **Pakiety Higieniczne:** Wnioskodawca powinien zapewnić spersonalizowane zestawy (inne dla kobiet, inne dla mężczyzn), zawierające m.in. szampon, mydło, przybory do golenia, szczoteczkę do zębów, ręczniki jednorazowe oraz czystą bieliznę na zmianę.

¹ Ogólnopolskie badanie liczby osób bezdomnych - Edycja 2024 -

<https://www.gov.pl/web/rodzina/ogolnopolskie-badanie-liczby-osob-bezdomnych-i>

² „Chciałam zrobić więcej”. Historia Agnieszki Sikory, Fundacji po DRUGIE i walki o godność młodych w kryzysie bezdomności. Ngo.pl, stan na dzień 17.02.2026 r.

- **Narzędzie edukacyjne – Instruktaż:** Kluczowym elementem jest trzystopniowa instrukcja (czynności przed, w trakcie i po kąpieli). Pełni ona dwie role:
 - **Dyscyplinującą:** Uczy oszczędnego gospodarowania ograniczonymi zasobami wody.
 - **Edukacyjną:** Przywraca nawyki dbania o czystość i odpowiedzialność za wspólną przestrzeń (sprzątanie po sobie).
- **Procedury:** Schemat organizacji pracy, zasady współpracy ze streetworkerami oraz dokumentacja operacyjna.

5. Lekcje z testowania: Jak uniknąć pułapek?

Testy przeprowadzone na terenie Stalowej Woli (3 razy w tygodniu, 3 punkty w mieście, średnio 6 godzin usług tygodniowo) dostarczyły ważnych wniosków:

- **Regularność to podstawa:** Zaufanie buduje się powoli. Dopiero powtarzalność usługi sprawia, że osoby bezdomne zaczynają traktować MPH jako bezpieczny punkt kontaktowy.
- **Przewidywanie trudności:** Wnioskodawca musi założyć, że nie każda zaplanowana usługa się odbędzie. Przyczynami mogą być:
 - Warunki pogodowe: Silne mrozy lub śnieżyce mogą uniemożliwić wyjazd w teren.
 - Stan użytkowników: Problemy z alkoholem lub nagłe hospitalizacje.
- **Efekty uboczne (pozytywne):** MPH często staje się „mostem” do innych usług. Dzięki relacji zbudowanej przy prysznicu, niektórzy użytkownicy decydują się na pobyt w schronisku, wizytę u lekarza czy podjęcie leczenia szpitalnego.

6. Matryca logiczna



Problem

Osoby bezdomne przebywające poza schroniskami mają krytycznie utrudniony dostęp do higieny, co pogłębia ich wykluczenie, obniża poczucie godności i pogarsza stan zdrowia



Rozwiązanie

Odwrócenie tradycyjnego modelu – to usługa dociera do klienta, eliminując bariery wstydu, lęku przed instytucjami czy barier logistycznych.



Cel główny

Włączenie MPH do katalogu lokalnych usług społecznych jako narzędzia pierwszego kontaktu i przywracania godności.

7. Strategia Komunikacji i BIG IDEA

Komunikacja nie może być „instytucjonalna”. Powinna opierać się na hasle:

„Idziemy tam, gdzie oni są”.

- **Filary przekazu:** Higiena jako prawo człowieka, a nie luksus; szacunek i partnerskie podejście; „małe kroki”, które prowadzą do dużych zmian (np. od kąpieli do terapii).
- **Ton:** Empatyczny, konkretny, pozbawiony oceniania i patosu.
- **Grupy docelowe:** Nie tylko osoby w kryzysie bezdomności, ale też **osoby zamieszkujące lokale bez łazienek** (np. z powodu nieuregulowanej sytuacji prawnej lokalu).

8. Potencjał rozwoju i inspiracje

Wnioskodawcy mogą rozwijać MPH, łącząc go z innymi usługami:

- **Pomoc medyczna:** Wzorem poznańskiego projektu „Mobilna pomoc medyczna”, MPH może być uzupełniony o proste zabiegi paramedyczne w terenie.
- **Pralnia i suszarnia:** Dodanie funkcji prania ubrań znacząco podnosi atrakcyjność usługi (inspiracja MOPS w Łodzi).
- **Inspiracje światowe:** Warto czerpać z doświadczeń **Lava Mae (USA)** – pionierów mobilnych pryszniców w autobusach, czy helsińskiego modelu **Housing First**, gdzie MPH wspiera proces wychodzenia z bezdomności.

9. Podsumowanie korzyści dla realizatora (np. Gminy/NGO):

Wdrożenie tej innowacji i przekształcenie jej w usługę pozwala na szybkie i elastyczne reagowanie na potrzeby tam, gdzie nie ma stałej infrastruktury. Dzięki **otwartej licencji** na dokumentację i specyfikację, Wnioskodawca otrzymuje gotowe narzędzie, które można łatwo zaadaptować do lokalnych warunków, budując nowoczesny i empatyczny wizerunek lokalnej pomocy społecznej.

Wdrożenie Mobilnego Punktu Higienicznego przynosi wyraźne korzyści zarówno osobom w kryzysie bezdomności, jak i całym społecznościom. Dostęp do kąpieeli i czystej odzieży podnosi poczucie godności, zmniejsza stygmatyzację i poprawia samopoczucie. Regularny kontakt z usługą pomaga odbudować nawyki higieniczne, a w przypadku części osób staje się impulsem do skorzystania z noclegowni i podjęcia dalszych kroków wychodzenia z kryzysu. Możliwość skorzystania z sanitariatów bezpośrednio w miejscach przebywania osób bezdomnych daje im poczucie bezpieczeństwa, intymności i realnie obniża stres związany z brakiem dostępu do wody.

Innowacja przynosi również korzyści społeczne: zmiana wyglądu zewnętrznego osób korzystających z MPH wpływa na większą akceptację ze strony otoczenia i ułatwia reintegrację. Mobilna łaźnia odciąża przestrzeń publiczną, ograniczając korzystanie z toalet w sklepach czy na stacjach benzynowych. Jest też rozwiązaniem tańszym i prostszym w utrzymaniu niż stacjonarne łaźnie, co ma znaczenie zwłaszcza dla gmin o mniejszych budżetach. Model sprawdza się również w pracy z osobami żyjącymi w skrajnym ubóstwie, które mają dach nad głową, ale nie mają dostępu do wody. Wypełnia lukę systemową, zapewniając podstawowe warunki egzystencjalne tam, gdzie brakuje standardowych form wsparcia.

Szlakiem ludzi bezdomnych

1. Istota innowacji - czego nie można zgubić

Szlakiem ludzi bezdomnych nie jest zakupem mobilnej łazienki, kontenera ani przyczepy z prysznicem. To usługa pierwszego kontaktu z osobami, które nie przychodzą do instytucji, nie korzystają regularnie ze schronisk i często są poza realnym zasięgiem OPS/CUS.

Istotą innowacji jest odwrócenie tradycyjnego modelu pomocy: nie czekamy, aż osoba w kryzysie bezdomności przyjdzie do urzędu, noclegowni czy schroniska, tylko usługa dociera tam, gdzie ta osoba faktycznie przebywa. Mobilny Punkt Higieniczny ma być jednocześnie miejscem kąpieli, odzyskiwania godności i pierwszą przestrzenią rozmowy ze streetworkerem lub pracownikiem pomocowym.

Tego nie należy pomijać:

- MPH musi być mobilny - jego sens polega na docieraniu do miejsc przebywania osób poza systemem;
- prysznic jest początkiem relacji, nie celem samym w sobie;
- usługa musi być regularna - zaufanie buduje się przez powtarzalność;
- przy usłudze powinien działać doświadczony streetworker lub osoba mająca realne doświadczenie pracy ulicznej z osobami w kryzysie bezdomności;
- osoba korzystająca z prysznica nie powinna być traktowana wyłącznie jako odbiorca interwencji, ale jako mieszkaniec znajdujący się w kryzysie, który może stopniowo odbudowywać kontakt z systemem wsparcia;
- po kąpieli osoba powinna mieć możliwość otrzymania czystej odzieży i obuwia - bez tego efekt higieniczny i psychologiczny usługi szybko znika;
- prysznic ma być pretekstem do czegoś więcej: rozmowy, kontaktu, pomocy medycznej, terapii, schronienia lub odbudowy relacji z systemem wsparcia.

Ważne ostrzeżenie dla podmiotu wdrażającego:

Nie należy robić z tej innowacji "mobilnej łaźni do odhaczenia usługi". Jeśli po kąpieli nie ma relacji, informacji, pakietu higienicznego, czystych ubrań, rozmowy i ścieżki do dalszego wsparcia, gmina kupuje sprzęt, ale nie tworzy usługi społecznej.

2. Jak przekształcić innowację w usługę społeczną

Innowacja Szlakiem ludzi bezdomnych ma sens szczególnie wtedy, gdy:

- osoby w kryzysie bezdomności przebywają w pustostanach, altanach, ogródkach działkowych, piwnicach, dworcach, okolicach sklepów, lasów lub miejsc sezonowej pracy;
- gmina nie ma własnej łaźni, noclegowni ani rozbudowanego zaplecza;
- osoby nie chcą lub nie potrafią wejść w klasyczną procedurę pomocy;
- OPS wie o kilku/kilkunastu osobach, ale kontakt z nimi jest nieregularny;
- problem higieny blokuje dalsze kroki: wizytę u lekarza, przyjęcie do schroniska, kontakt z rodziną, rozmowę o leczeniu lub dokumentach.

Usługa powinna działać jako mobilny punkt godności i pierwszego kontaktu:

- podmiot identyfikuje miejsca przebywania osób;
- ustala stały harmonogram przyjazdów;
- zapewnia prysznic, pakiet higieniczny, czystą bieliznę, podstawową odzież i obuwie;
- przy usłudze obecny jest streetworker/pracownik pomocowy;
- każda wizyta jest okazją do krótkiej rozmowy, nie do przesłuchania;
- osoba może stopniowo przejść do dalszych usług: schronienia, lekarza, leczenia, dokumentów, świadczeń, mieszkania wspieranego.

W praktyce mobilny punkt może być rozszerzany o inne elementy pierwszego kontaktu:

- gorące napoje;
- prosty posiłek;
- wymianę odzieży;
- pomoc przedmedyczną;
- podstawowe działania ograniczania szkód związanych z uzależnieniami;
- wsparcie w sprawach formalnych i urzędowych;
- podstawowe poradnictwo prawne, np. dotyczące dokumentów, zadłużenia, świadczeń lub kontaktu z instytucjami.

To podejście dobrze łączy się z filozofią Housing First: pomoc zaczyna się od uznania godności i potrzeb osoby, a nie od wymagania, by najpierw spełniła warunki "gotowości" do wsparcia. MPH nie jest Housing First, ale może być bramą relacyjną do dalszych form pomocy.

3. Mapa wdrożenia usługi - krok po kroku

Etap przygotowania usługi - do 6 miesięcy

1) Zmapować miejsca, nie tylko osoby

Podmiot wdrażający powinien zacząć od mapy miejsc:

- pustostany;
- altany i ogródki działkowe;
- okolice dworców, przystanków, sklepów, mostów;
- miejsca sezonowego nocowania;
- lokale bez łazienki;
- miejsca wskazane przez policję, straż gminną, sołtysów, parafie, pracowników socjalnych.

Warto przy tym rozpoznać:

- gdzie osoby śpią;
- gdzie się ogrzewają;
- gdzie próbują dbać o higienę;
- gdzie najczęściej pojawiają się konflikty lub interwencje.

2) Wybrać lokalny model działania

Nie trzeba zaczynać od dużego pojazdu i rozbudowanego zespołu. Model usługi powinien być dopasowany do lokalnej skali problemu, możliwości organizacyjnych oraz doświadczenia podmiotu wdrażającego.

Możliwe rozwiązania:

- zakup lub adaptacja mobilnego punktu higienicznego;
- zlecenie realizacji usługi organizacji pozarządowej lub podmiotowi mającemu doświadczenie w pracy z osobami w kryzysie bezdomności;
- wykorzystanie istniejącego pojazdu lub zaplecza technicznego i stopniowe rozwijanie usługi;
- uruchamianie MPH sezonowo lub w określone dni, jeśli skala problemu jest niewielka;
- pilotażowe wdrożenie usługi w jednej lokalizacji przed rozszerzeniem działań.

Najważniejsze jest jednak nie samo wyposażenie, ale doświadczenie zespołu. Osoby w kryzysie bezdomności bardzo szybko wyczuwają sztuczność, dystans lub nadmiernie formalny styl

kontakty. Dlatego przy usłudze powinny działać osoby mające doświadczenie streetworkingowe lub praktyczną znajomość środowiska ulicznego.

3) Ustalić punkty postoju i harmonogram

Testy innowacji pokazały, że regularność jest podstawą budowania zaufania.

Dlatego lepiej mieć:

- 1-2 stałe miejsca działania;
- stałe dni i godziny;
- przewidywalny harmonogram kontaktu,

niż wiele lokalizacji bez ciągłości i rozpoznawalności usługi.

Podstawowe informacje przekazywane odbiorcom powinny obejmować:

- miejsce postoju;
- terminy i godziny działania;
- orientacyjny czas postoju;
- zasady korzystania z usługi;
- zakres dostępnego wsparcia;
- możliwość rozmowy ze streetworkerem lub pracownikiem pomocowym;
- informację o konieczności podstawowego dokumentowania udziału w usłudze zgodnie z zasadami realizacji grantu.

4) Zabezpieczyć kwestie techniczne

Szczegółowe rozwiązania techniczne mobilnego punktu higienicznego znajdują się w dokumentacji innowacji, obejmującej między innymi specyfikację przyczepy lub kontenera, wyposażenie oraz procedury operacyjne.

Na etapie planowania usługi podmiot wdrażający powinien skupić się przede wszystkim na zapewnieniu bezpiecznych i stabilnych warunków świadczenia wsparcia.

W praktyce należy sprawdzić:

- dostęp do wody;
- możliwość odprowadzania ścieków;
- dostęp do zasilania;
- miejsca bezpiecznego postoju;

- możliwość działania usługi w okresie jesienno-zimowym;
- zasady bezpieczeństwa personelu i użytkowników;
- organizację sprzątania i dezynfekcji;
- sposób transportu i serwisowania mobilnego punktu.

Warto również od początku przygotować zaplecze wspierające usługę, w szczególności:

- miejsce przechowywania odzieży i obuwia;
- sposób segregowania i wydawania ubrań;
- możliwość prania lub suszenia odzieży;
- podstawowe wyposażenie do pomocy przedmedycznej;
- przestrzeń umożliwiającą spokojną rozmowę ze streetworkerem lub pracownikiem pomocowym.

5) Zaplanować pakiety higieniczne

Opis innowacji wskazuje, że pakiety powinny być dostosowane do potrzeb kobiet i mężczyzn oraz zawierać między innymi: szampon, mydło, przybory do golenia, szczoteczkę do zębów, ręczniki jednorazowe, podpaski oraz czystą bieliznę.

Pakiet higieniczny nie powinien być traktowany jako dodatek do usługi. Dla wielu osób możliwość wyjścia spod prysznica w czystej bieliźnie i ubraniu ma równie duże znaczenie jak sama kąpiel - zarówno pod względem higieny, jak i poczucia godności oraz gotowości do dalszego kontaktu z pomocą.

W praktyce szczególnie potrzebne będą:

- skarpety;
- bielizna;
- koszulki;
- bluzy;
- buty;
- odzież zimowa.

6) Przygotować rolę streetworkera/pracownika pomocowego

Rolą streetworkera nie powinno być wyłącznie kierowanie osoby do systemu pomocy, ale przede wszystkim budowanie relacji i stopniowego kontaktu z osobą pozostającą poza systemem wsparcia.

Podstawowe elementy tej pracy to między innymi:

- rozmowa prowadzona bez presji i oceniania;
- przekazywanie informacji o dostępnych formach pomocy;
- rozpoznanie podstawowych problemów zdrowotnych i sytuacji kryzysowych;
- zachęcanie do kolejnego kontaktu;
- wsparcie w wykonaniu pierwszego kroku, np. w sprawach dokumentów, kontaktu z lekarzem, schronieniem, leczeniem, posiłkiem lub pomocą socjalną.

Bardzo ważne jest, aby przy usłudze działały osoby rozumiejące specyfikę bezdomności ulicznej. W praktyce osoby wspierane znacznie lepiej reagują na streetworkerów mających doświadczenie terenowe, a czasem także osobiste doświadczenie kryzysu bezdomności. Zmniejsza to dystans i poczucie oceniania.

W Polsce streetworking przez lata rozwijał się praktycznie, ale nie był mocno opisany ustawowo; od 2025 r. zawód streetworkera został wpisany do klasyfikacji zawodów. Dlatego gmina powinna opisać tę funkcję operacyjnie: jako pracę terenową przy mobilnej usłudze higienicznej.

7) Przygotować procedurę reagowania w sytuacjach trudnych i kryzysowych

Testowanie innowacji pokazało, że realizacja usługi terenowej wymaga przygotowania na sytuacje nieprzewidywalne. Na możliwość przeprowadzenia działania mogą wpływać między innymi warunki pogodowe, stan zdrowia osób korzystających z usługi, kryzysy psychiczne, używanie alkoholu lub innych substancji psychoaktywnych.

Procedura powinna określać między innymi:

- kiedy usługa może zostać czasowo odwołana lub ograniczona ze względów bezpieczeństwa;
- w jaki sposób informować o zmianie harmonogramu;
- jak reagować na zachowania agresywne lub sytuacje konfliktowe;
- co robić w przypadku zagrożenia zdrowia lub życia;
- kiedy należy wezwać pogotowie ratunkowe, policję lub inne służby;
- jak chronić prywatność i godność osób korzystających z usługi;
- jak dokumentować sytuacje trudne i interwencje.

Warto również przygotować podstawowe procedury dotyczące:

- pomocy osobom z problemami stóp, ranami lub odleżynami;
- udzielania podstawowej pomocy przedmedycznej;

- reagowania na silne objawy uzależnień lub kryzysów psychicznych;
- postępowania wobec osób wymagających pilnej pomocy medycznej;
- zasad bezpiecznej pracy personelu i wolontariuszy w terenie.

Etap świadczenia usługi - minimum 12 miesięcy

Usługa powinna działać w regularnym rytmie i obejmować:

- stałe wyjazdy terenowe według harmonogramu;
- możliwość skorzystania z prysznica i pakietu higienicznego;
- wydawanie czystej odzieży i obuwia;
- kontakt ze streetworkerem lub pracownikiem pomocowym;
- podstawowe wsparcie informacyjne, zdrowotne lub socjalne;
- monitorowanie dalszych potrzeb osób korzystających z usługi;
- okresową ocenę lokalizacji i sposobu działania usługi.

Najważniejsze jest zachowanie regularności, przewidywalności i relacyjnego charakteru wsparcia.

Dla wielu osób pierwszy kontakt przy mobilnym punkcie higienicznym może być początkiem stopniowego odbudowywania zaufania do systemu pomocy.

4. Co jest obowiązkowe, a co można rozszerzać

Elementy konieczne

Bez tych elementów usługa traci swój relacyjny i terenowy charakter:

- mobilny punkt higieniczny docierający do miejsc przebywania osób w kryzysie bezdomności;
- regularny i przewidywalny harmonogram działania;
- podstawowy pakiet higieniczny;
- możliwość zmiany bielizny i odzieży;
- obecność doświadczonego streetworkera lub pracownika pomocowego;
- procedury bezpieczeństwa dla użytkowników i personelu;
- zasady utrzymania czystości oraz gospodarowania wodą i ściekami;
- dokumentowanie kontaktów i podstawowych efektów usługi;
- możliwość przekierowania osoby do dalszych form wsparcia.

Elementy opcjonalne

Usługa może zostać rozszerzona o dodatkowe działania odpowiadające na lokalne potrzeby:

- mobilną pralnię lub możliwość suszenia odzieży;
- punkt wymiany odzieży i obuwia;
- podstawowe wsparcie przedmedyczne;
- pomoc przy problemach ze stopami, ranami lub odleżynami;
- konsultacje pielęgniarskie, opatrunki lub działania profilaktyczne;
- wsparcie fryzjera lub barbera;
- pomoc w sprawach formalnych i dokumentach;
- mobilny punkt poradnictwa socjalnego;
- współpracę z lekarzem, terapeutą uzależnień lub psychologiem;
- gorący napój lub prosty posiłek;
- działania ograniczania szkód związanych z uzależnieniami;
- współpracę z noclegownią, schroniskiem lub mieszkaniem wspieranym;
- działania skierowane do osób mieszkających w lokalach bez dostępu do podstawowych warunków higienicznych.

5. Jak poradzić sobie z typowymi barierami JST

Bariera 1: "U nas nie ma osób w kryzysie bezdomności"

W mniejszych miejscowościach często oznacza to raczej brak kontaktu z osobami pozostającymi poza systemem wsparcia niż rzeczywisty brak problemu. Osoby mogą przebywać w pustostanach, altanach i ogródkach działkowych, lokalach bez dostępu do podstawowych warunków sanitarnych, u znajomych lub rodziny, sezonowo przemieszczać się między miejscowościami.

Bariera 2: "Skala problemu jest zbyt mała na własny punkt mobilny"

Usługa nie musi od początku przyjmować rozbudowanej formy organizacyjnej. Możliwe jest rozpoczęcie od: ograniczonego harmonogramu wyjazdów, jednej lokalizacji pilotażowej, prostszego modelu organizacyjnego, współpracy z organizacją posiadającą doświadczenie terenowe.

Bariera 3: "Nie mamy streetworkera"

To jedna z najważniejszych barier przy wdrażaniu usługi. Osoby przypadkowe lub niemające doświadczenia pracy terenowej mogą mieć trudność z budowaniem relacji z osobami w kryzysie bezdomności.

Dlatego warto:

- współpracować z organizacjami posiadającymi doświadczenie streetworkingowe;
- korzystać ze wsparcia doświadczonych zespołów terenowych;
- szkolić osoby mające doświadczenie pracy środowiskowej;
- budować zespół oparty na relacyjności, cierpliwości i regularnym kontakcie.

Bariera 4: "Obawiamy się konfliktów z mieszkańcami"

Punkt postoju powinien być jednocześnie dostępny dla osób korzystających z usługi i bezpieczny organizacyjnie.

Komunikacja wokół usługi powinna podkreślać ochronę zdrowia i bezpieczeństwa, przeciwdziałanie wykluczeniu, poprawę warunków higienicznych, ograniczanie sytuacji kryzysowych w przestrzeni publicznej.

Bariera 5: "Osoby będą pod wpływem alkoholu lub innych substancji"

W pracy terenowej należy zakładać możliwość występowania takich sytuacji. Dlatego konieczne są jasne procedury bezpieczeństwa określające:

- kiedy osoba może skorzystać z usługi;
- kiedy należy ograniczyć lub przerwać kontakt ze względów bezpieczeństwa;
- jak reagować w sytuacjach kryzysowych;
- kiedy konieczne jest wezwanie pomocy medycznej lub służb.

Nawet w sytuacji odmowy ważne jest zachowanie relacyjnego charakteru kontaktu i możliwość zaproszenia osoby do ponownego skorzystania z usługi w bezpiecznych warunkach.

Bariera 6: "Sam prysznic nie rozwiąże problemu"

Sama możliwość kąpieli nie rozwiązuje problemu bezdomności ani wykluczenia społecznego.

Dlatego mobilny punkt higieniczny powinien być początkiem dalszego wsparcia, a nie jego końcem.

W praktyce usługa może prowadzić do:

- nawiązania regularnego kontaktu z osobą pozostającą poza systemem;

- wsparcia medycznego lub terapeutycznego;
- pomocy w sprawach dokumentów i świadczeń;
- skierowania do schronienia lub mieszkania wspieranego;
- kontaktu z leczeniem uzależnień;
- odbudowy relacji rodzinnych;
- stopniowego włączania osoby w dalsze formy pomocy środowiskowej.

To “coś więcej” powinno być przygotowane wspólnie z podmiotami mającymi doświadczenie pracy z osobami w kryzysie bezdomności i dostosowane do lokalnych możliwości wsparcia.

6. Działania wspierające wdrożenie innowacji

Działania wspierające powinny pomagać osobie przejść od kąpieli do kolejnego kroku.

Rekomendowane działania:

- pakiet higieniczny i bielizna;
- wymiana odzieży i obuwia;
- gorący napój lub prosty posiłek;
- krótka karta informacyjna;
- dyżur streetworkera;
- mobilne wsparcie medyczne;
- pomoc przy problemach ze stopami;
- kontakt z terapią uzależnień;
- pomoc w przygotowaniu wniosków o wydanie dokumentów, np. dowodu osobistego;
- ścieżka do schroniska lub mieszkania wspieranego;
- współpraca z lokalnym lekarzem/POZ;
- działania ograniczania szkód związanych z uzależnieniami;
- dyżur zimowy.

7. Jak wykorzystać wdrożenie do trwałej zmiany lokalnej

Po zakończeniu grantu mogą pozostać:

- lepsza wiedza o miejscach przebywania osób pozostających poza systemem wsparcia;
- wypracowana procedura pracy terenowej;
- lokalny zespół lub partnerstwo wspierające działania streetworkingowe;

- regularny harmonogram mobilnej usługi higienicznej;
- współpraca między podmiotami społecznymi, zdrowotnymi i organizacjami pracującymi w terenie;
- większa wiedza o potrzebach osób pozostających w kryzysie bezdomności;
- procedury reagowania w okresie zimowym i sytuacjach kryzysowych;
- standard pierwszego kontaktu z osobami pozostającymi poza systemem pomocy;
- lepsza koordynacja kierowania do dalszych form wsparcia, leczenia lub schronienia;
- większe rozumienie zjawiska bezdomności ulicznej i ukrytej w społeczności lokalnej.

Najważniejsza zmiana myślenia:

Mobilny Punkt Higieniczny przestaje być traktowany wyłącznie jako forma pomocy higienicznej.

Staje się narzędziem pracy terenowej, budowania relacji i docierania do osób, które często od lat pozostają poza regularnym kontaktem z instytucjami i systemem wsparcia.

8. Możliwe kierunki rozwoju usługi lokalnie

Po wdrożeniu pilotażowym można rozwijać usługę w kilku kierunkach:

- rozszerzenie mobilnego punktu higienicznego o wydawanie odzieży i obuwia;
- połączenie usługi z podstawowym wsparciem zdrowotnym lub przedmedycznym;
- rozwój mobilnego streetworkingu połączonego z wydawaniem napojów lub posiłków;
- uruchomienie mobilnej pralni lub punktu wymiany odzieży;
- rozwój działań ograniczania szkód związanych z uzależnieniami;
- stworzenie sezonowych procedur wsparcia zimowego;
- rozwój lokalnych działań streetworkingowych;
- połączenie usługi z programami mieszkaniowymi i środowiskowymi;
- rozwój współpracy z organizacjami społecznymi i podmiotami zdrowotnymi;
- tworzenie lokalnych modeli pierwszego kontaktu z osobami pozostającymi poza systemem wsparcia.

9. Szybka checklista dla grantobiorcy przed zaplanowaniem wdrożenia

- Czy zachowujemy istotę innowacji: docieranie z usługą do osób pozostających poza systemem wsparcia?
- Czy przy usłudze działa doświadczony streetworker lub pracownik pomocowy?
- Czy rozpoznano miejsca przebywania osób wymagających wsparcia?

- Czy mobilny punkt higieniczny będzie działał regularnie i w przewidywalnym harmonogramie?
- Czy zapewniono pakiety higieniczne, czystą bieliznę, odzież i obuwie?
- Czy przewidziano możliwość podstawowej pomocy przedmedycznej lub wsparcia zdrowotnego?
- Czy przygotowano procedury reagowania w sytuacjach kryzysowych, np. podczas mrozów, agresji lub zagrożenia zdrowia?
- Czy zaplanowano dalsze formy wsparcia po pierwszym kontakcie z osobą korzystającą z usługi?
- Czy usługa ma charakter relacyjny i środowiskowy, a nie wyłącznie infrastrukturalny?
- Czy po zakończeniu grantu pozostanie trwały model pracy terenowej i współpracy z osobami w kryzysie bezdomności?

SZLAKIEM LUDZI BEZDOMNYCH

INNOWACJA W POSTACI USŁUGI SPOŁECZNEJ



CO?

NA CZYM POLEGA?



Mobilny Punkt Higieniczny (MPH) – prysznic i miejsce spotkania dla osób w kryzysie bezdomności.

Usługa dociera do miejsc, w których osoby bezdomne rzeczywiście przebywają.

MPH to nie tylko kąpiel – to pierwszy kontakt, rozmowa ze streetworkerem i budowanie zaufania.

KLUCZOWE ELEMENTY, KTÓRYCH NIE WOLNO ZGUBIĆ:

- ✓ Mobilność – to my docieramy do człowieka
- ✓ Prysznic jako początek relacji, nie cel sam w sobie
- ✓ Regularność – zaufanie buduje się przez powtarzalność
- ✓ Obecność streetworkera i rozmowa
- ✓ Godność, szacunek i brak oceniania
- ✓ Możliwość dalszych kroków po pierwszym kontakcie



JAK?

ETAPY WDROŻENIA
USŁUGI

1

ROZPOZNANIE TERENU I OSÓB



Identyfikacja miejsc przebywania osób w kryzysie bezdomności i ustalenie potrzeb.

2

USTALENIE HARMONOGRAMU I PUNKTÓW POSTOJU



Stale dni i godziny, aby usługa była przewidywalna i dostępna.

3

ŚWIADCZENIE USŁUGI W TERENIE



Dostęp do prysznica, podstawowych środków higieny i czystej odzieży.

4

ROZMOWA I BUDOWANIE RELACJI



Obecność streetworkera – rozmowa, informacja, motywowanie do zmiany, wsparcie w kryzysie.

5

KIEROWANIE DO DALSZEGO WSPARCIA



Połączenie z ofertą gminy i partnerów: schronienie, leczenie, dokumenty, pomoc społeczna.



PO CO?

GŁÓWNA KORZYŚĆ
DLA GMINY



Ochrona zdrowia i życia osób w kryzysie



Więcej osób wraca do systemu pomocy



Mniej interwencji kryzysowych i kosztów



Budowanie relacji i zaufania w lokalnej społeczności



Mała infrastruktura, która otwiera drogę do zmiany życia człowieka.



Prysznic daje ulgę. Rozmowa daje nadzieję. Wsparcie daje szansę na nowe życie.

MPH to pierwszy krok do samodzielności – zanim pojawi się dramat.